

رأب الحوض الكلوي عملية جراحية لإصلاح تضيق في الموصل بين الكلية والحالب (الأنبوب الذي ينقل البول إلى المثانة). يُعرقّل هذا التضيق تصريف البول فيسبب ألمًا وعدوى أو تلفًا كلويًا. تُزيل العملية الجزء المسدود وتُعيد بناء وصل واسع يُصرف بحرية — وهي الإصلاح الأكثر ديمومةً بمعدل نجاح يتجاوز 90%.

عن هذه العملية

في الجزء العلوي من الحالب حيث يلتقي بالحوض الكلوي، قد يحدث تضيق يُبطئ تصريف البول. وأحيانًا يضغط وعاء دموي متقاطع على هذا الموصل. يُسمى هذا انسداد الموصل الحالب الحوضي (UPJ). في رأب الحوض الكلوي يقوم الجراح بـ:

- إزالة الجزء المتضيق
- خياطة الحالب السليم بالحوض الكلوي في وصل واسع على شكل قمع
- وضع دعامة داخلية ناعمة لإبقاء الوصل مفتوحًا أثناء الشفاء

تُجرى العملية في الغالب بالمنظار الروبوتي أو التقليدي عبر ثقب صغيرة؛ وأحيانًا بشق مفتوح واحد.

هل هو آمن؟

رأب الحوض الكلوي عملية راسخة وفعّالة جدًا بمعدل نجاح يتجاوز 90%. كأي جراحة، تحمل بعض المخاطر — كالنزيف أو العدوى أو تسرب بول مؤقت (تُعالج الدعامة والصرف عادةً). عودة التضيق نادرة وتستجيب للعلاج في الغالب.

تعلم المصطلحات

الكلية

العضو الذي يُصَفّي الدم ويُنتج البول.

الحالب

الأنبوب الذي ينقل البول من الكلية إلى المثانة.

UPJ

الموصل الحالب الحوضي — حيث تلتقي الكلية بالحالب؛ موضع الانسداد.

الحوض الكلوي

الجيب على شكل قمع حيث يتجمع البول قبل دخول الحالب.

الدعامة الحالية

أنبوب داخلي ناعم («دبل جي») يُبقي الإصلاح مفتوحًا أثناء الشفاء.

الوعاء المتقاطع

وعاء دموي يضغط على الموصل فيسبب الانسداد.

استسقاء الكلية

تورم الكلية بسبب احتباس البول خلف الانسداد.

روبوتي / منطاري

جراحة بالثقب الصغيرة عبر شقوق دقيقة.

هل سيؤلم؟ تُجرى العملية تحت التخدير العام فلا تشعر بشيء أثناءها. بعدها، توقع ألمًا خفيفًا عند الشقوق الصغيرة وأحيانًا إزعاجًا في الكتف أو البطن من الغاز المستخدم في الجراحة المنظارية. قد تُسبب الدعامة الداخلية إلحاقًا للتبول أو وجعًا خفيفًا في الخصرة أثناءه. يمكث معظم المرضى 1-2 ليلة؛ وتستغرق العملية في الغالب 2-3 ساعات.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

بعد الجراحة

- تُجرى تحت التخدير العام — اتبع جميع تعليمات الجراحة (الصيام والأدوية التي يجب إيقافها، بما فيها مضادات التخثر).
- تحليل البول يكشف العدوى — يجب علاجها أولًا.
- خطط لوجود دعامة داخلية نحو 4-6 أسابيع، ورتّب من يصطحبك للمنزل.

أخبر فريقك مسبقًا إذا كنت:

- تتناول مضادًا تخثر أو لديك عدوى بولية حالية
- أجريت سابقًا جراحة في الكلية أو البطن

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

- 1 تنام تحت التخدير وتُعطى مضادات حيوية وقائية.
- 2 يُجري الجراح ثقبًا صغيرًا (أو شقًا مفتوحًا واحدًا) ويكشف الموصل المسدود.
- 3 يُزيل الجزء المتضيق ويُعيد تشكيل الحوض الكلوي.
- 4 يخطب الحالب السليم بالحوض على شكل قمع فوق دعامة؛ وقد يُترك صرّاف صغير ثم تُغلق الشقوق.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة
- ألم شديد أو متصاعد في الخصرة أو البطن
- نزيف غزير أو جلطات دموية في البول
- عدم القدرة على التبول، أو غثيان وقيء مستمر
- احمرار أو ألم أو إفراز متزايد عند أحد الشقوق

ثلاثة أمور تذكّرها

1. رأب الحوض الكلوي يُزيل انسداد مخرج الكلية ويُعيد بناء وصل واسع — وهو الإصلاح الأكثر ديمومةً، ويُجرى عادةً بنقوب صغيرة.
2. للتحضير: اتبع تعليمات الصيام والأدوية، وعالج أي عدوى أولًا، وخطط لدعامة داخلية نحو 4-6 أسابيع، ورتّب من يصطحبك.
3. توقع أن تُسبب الدعامة إلحاقًا أو وجعًا خفيفًا بالخصرة حتى تُزال في العيادة. اتصل فورًا عند الحمّى أو الألم الشديد أو النزيف الغزير أو عدم القدرة على التبول.